

Pr djelouat

Cours destiné aux étudiants 3ème année médecine

Physiopathologie Occlusion intestinale aigue

Année universitaire 2025-2026

I. Définition :

- L'occlusion intestinale est une urgence medico-chirurgicale qui est définie comme étant un arrêt brutal du transit intestinal responsable d'un arrêt des matières et des gaz
- Il en résulte une distension intestinale en **amont** de l'obstacle
- La cause la plus fréquente est l'occlusion intestinale par obstacle mécanique, soit par bride, soit par tumeur

II. Rappel physiologique :

L'intestin est un organe creux, dynamique, qui comprend :

- 6,5 m d'intestin grêle (jéjunum et iléon), dont la partie centrale mobile
- 1,5 m de colon, succession de segments mobiles et fixes
- La motricité intestinale est assurée par les contractions **des couches musculaires lisses**, longitudinales et circulaires

Plusieurs facteurs peuvent moduler la progression des aliments:

- Nerveux
- Hormonaux
- Vasculaires
- Contenu du tractus digestif

Contenu de l'intestin:

- Air
- Liquides de sécrétions digestives
- Aliments
- Bactéries (colon+++)

La sécrétion de l'intestin est de 7 litres/jour :

- Estomac **2,5 l**
- Sécrétions bilio- pancréatiques **2l**
- Intestin grêle **2 l**
- Gros intestin **0,4 l**

Principales caractéristiques du système nerveux:

a) **Système nerveux extrinsèque :**

- Système nerveux sympathique: ↓ motricité intestinale et ↑ tonus des sphincters
- Système nerveux parasympathique: ↑ motricité intestinale et ↓ du tonus des sphincters

b) **Système nerveux intrinsèque ou entérique:**

↑ Péristaltisme, sécrétion gastro-intestinale et débit sanguin local

III. Physiopathologie

a. **Classification** : On distingue :

- **Selon le siège de l'arrêt :**

- a. Occlusion haute : duodénum et grêle
- b. Occlusion basse : colon et rectum

- **Selon le mécanisme :**

- a) Occlusion mécanique par un obstacle intra- ou extra luminal
- b) Occlusion fonctionnelle sans obstacle apparent

b. Conséquences :

Quelle que soit l'origine de l'occlusion la paroi intestinale est le siège d'une désynchronisation de l'activité musculaire responsable l'arrêt du transit intestinal

- En cas d'obstruction simple, progressivement se produit **une dilatation intestinale** avec **stase digestive** responsable de :

- a) Troubles hydro électrolytiques
- b) ↑ De la pression intra abdominale
- c) Translocation bactérienne

- En cas d'occlusion par strangulation le début est brutale et la dilatation est précoce et risque de perforation

1. Désordres hydro électrolytiques

- Séquestration liquidienne dans la lumière digestive et la paroi par ↑ de la perméabilité capillaire entraînant des désordres volumiques et hydro électrolytiques ; Déshydratation Hypovolémie Surtout hypokaliémie

- En cas d'occlusion située au niveau pylorique ou gastrique: pertes en eau = pertes en sodium, donc riches en acide et en potassium entraînant une **alcalose métabolique hypochlorémique** et **hypokaliémique**

- Plus tardivement, les pertes d'eau > pertes de sodium entraînant une déshydratation intracellulaire (**hypernatrémie**)

- Dans les occlusions basses : les troubles sont plus complexes, il va y avoir une déshydratation extracellulaire associée à une **acidose métabolique**

2. Translocation bactérienne

- Le passage de microorganismes vivants (bactéries, levures) vers les ganglions lymphatiques est favorisée par :

- Déséquilibre de la flore intestinale avec pullulation bactérienne
- Lésion de la barrière muqueuse intestinale
- Troubles de la défense immunitaire

- La conséquence est une péritonite par diffusion ou perforation

3. Augmentation de la pression intra-abdominale

Elle est responsable de dysfonctions d'organes:

a. Sur le plan respiratoire:

- ↓ de la course diaphragmatique
- ↓ la compliance pulmonaire
- Effet shunt

b. Sur le plan cardiovasculaire:

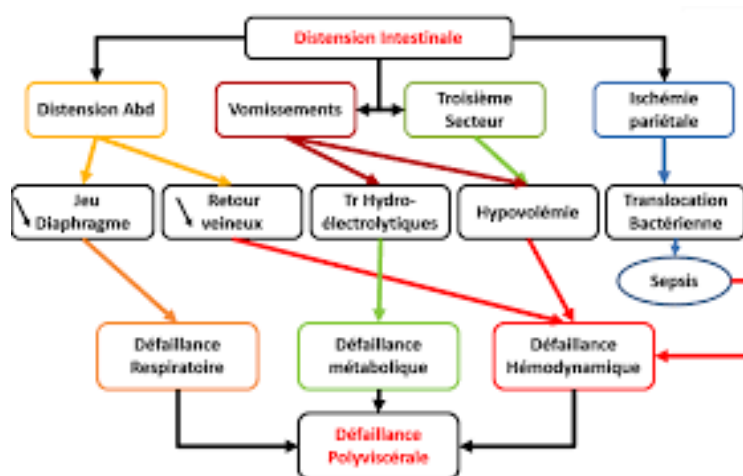
- ↓ du retour veineux
- ↓ de la contractilité myocardique
- ↓ du débit cardiaque

C. Sur le plan endocrinien :

- Hyperactivité sympathique
- ↑ de la sécrétion d'hormone antidiurétique
- ↓ du débit de filtration glomérulaire
- Altération de la fonction rénale

d.. Sur le plan cérébral :

- ↑ de la pression intracrânienne par ↓ du retour veineux dans la veine cave supérieure.



c. Mécanismes

- On distingue deux types :
 1. Soit par un obstacle et on parle alors d'une occlusion mécanique
 2. Soit par une paralysie et on parle alors d'une occlusion fonctionnelle

1. Occlusion mécanique : 2 mécanismes essentiels :

- Obstruction: liés à un obstacle pariétal (tumeur) ou à un corps étranger migrant (calcul, bézoard...)
- Strangulation: bride, volvulus, invagination, où il existe une oblitération des vaisseaux

a. Occlusions par obstacle

Représente 60 % à 80 % pour les occlusions du grêle et 20 % à 40 % pour les occlusions coliques

❖ Occlusions par obstacle intra pariétal

Au niveau de l'intestin grêle:

- Tumeurs bénignes: rarement révélées par un syndrome occlusif
- Tumeurs malignes: 15 % des occlusions du grêle
- Sténoses pariétales:
 - Cicatricielle (grêle radique) - Inflammatoire (maladie de Crohn) - Tuberculeuse : cause rare

Au niveau du côlon et du rectum

- Cancer du côlon: cause la plus fréquente d'occlusion colique
- Maladies inflammatoires: rarement responsables d'occlusion intestinale

❖ Occlusions par obstacle intraluminal

Au niveau de l'intestin grêle

- Iléus biliaire: fait suite à la migration d'un volumineux calcul biliaire par une fistule cholécystoduodénale
- Phytobézoard
- Corps étranger : ingestion accidentelle (prothèses dentaires), ou intentionnelle chez les patients atteints de troubles psychiatriques
- Ascariidose : parasitose, due à l'*Ascaris lumbricoides*

Au niveau du côlon et du rectum

- Corps étrangers – Fécalomes

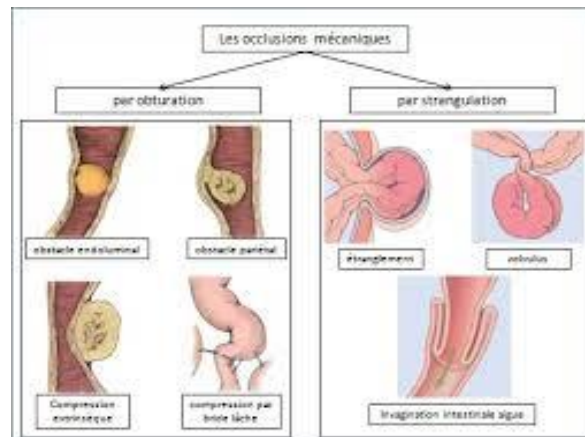
❖ Occlusions par obstacle extraluminal : Souvent intestin grêle

- Carcinose péritonéale
- Tumeur de voisinage
- Abscess

b. Occlusions par strangulation

- Occlusions sur brides ou adhérences péritonéales : siège le plus souvent au niveau du grêle dont l'origine peut être : postopératoire, inflammatoire ou traumatique
- Volvulus : 80 % côlon pelvien et sigmoïde
- Hernies étranglées : hernie inguinale, crurale, ou ombilicale-

- Invaginations intestinales: fréquentes chez le nourrisson



2. Occlusion fonctionnelle : Elle correspond à un iléus paralytique suite à :

- Ischémie mésentérique
- Foyer infectieux (appendicite ou péritonite)
- Foyer inflammatoire (pancréatite aiguë)
- épanchements (péritonéal ou retro-péritonéal)
- Douleur (colique néphrétique)
- Hypokaliémie

3. Cas particuliers

a. L'iléus postopératoire : est un arrêt des matières et des gaz dans les suites d'un geste chirurgical, La distinction entre un iléus postopératoire prolongé et la survenue d'une complication postopératoire précoce n'est pas toujours aisée

b. La colectasie aiguë idiopathique ou syndrome d'Ogilvie: est une Dilatation du côlon sans cause organique, dont L'origine physiopathologique est vraisemblablement due à un déséquilibre entre le tonus sympathique et parasympathique

IV. Diagnostic

Le diagnostic de l'occlusion intestinale est clinique marqué par l'installation :

- Douleur abdominale
- Vomissement
- Arrêt des matières et des gaz
- L'examen clinique retrouve :
 - un silence auscultatoire qui est pathognomonique de l'arrêt des matières et des gaz
 - une distension abdominale avec tympanisme à la percussion
- L'examen est par la suite orienté sur la recherche :
 - Eléments étiologiques (cicatrice abdominale, palpation des orifices herniaires)
 - Signes de mauvaise tolérance (état de choc, déshydratation)

- Imagerie

- Radiographie de l'abdomen sans préparation:
 - a. au niveau de l'intestin grêle :
 - Présence anormale d'air dans l'intestin au niveau central
 - Niveaux hydroaériques, plus larges que hauts
 - Dilatation intestinale
 - b. au niveau colique :
 - Dilatation du cadre colique, en amont de l'obstacle
 - Niveaux hydroaériques plus hauts que larges
- Scanner(TDM) : est un Examen de référence +++

V. Traitement : Nécessite d'une équipe de réanimation médicochirurgicale

Le temps du traitement médical préalable comprend :

- Aspiration gastrique +++
- Réanimation pour obtenir un remplissage correcte
- Ce temps est d'autant plus court que la vitalité de l'intestin est menacée

Le traitement chirurgical doit toujours:

- Lever l'obstacle
- Enlever les segments nécrosés ou douteux
- Rétablir la continuité dans un second temps ou pendant l'intervention si les conditions locales et/ou générales le permettent